Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent6vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5098349-22.2022.8.21.0001/RS

AUTOR: MARCELA VIEIRA DEWES

RÉU: UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.

SENTENÇA

MARCELA VIEIRA DEWES propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBERTURA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE em face de UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA aludindo que fora diagnosticada em 2006 com carcinoma de ovário seroso de baixo grau (CID 10 C56), EC IV, mutação KRAS-Q61R, infiltrado e metastático, tendo realizado cirurgias para retirada de tumores. Foi submetida à quimioterapia e recebera *carboplatina*, *paclitaxel*, *femara*, *falodex*, entre outros medicamentos. Aduziu que apresenta progressão da doença no abdome, com crescimento de lesão infiltrada no ventre e implantes secundários, e diante da evolução da doença e superação dos tratamentos anteriores, necessita do medicamento *Trametinibe* (nome comercial Mekinist®), dose de 2mg ao dia. Disse que a medicação é aprovada na ANVISA, havendo comprovação baseada em evidência científica da sua eficácia e recomendação de órgão técnico de renome internacional, mas foi negada pela ré por falta de previsão regulamentar (*off label*). Sustentou ser consumidora do plano de saúde Unimed (ambulatorial e hospitalar), com pagamento em dia. Disse que o câncer em questão é raro, com poucas alternativas de tratamento, havendo publicação em revista científica que o aludido medicamento representa média de sobrevida livre de progressão de 13 (treze) meses comparado com 07 (sete) meses das alternativas anteriormente utilizadas ou descartadas. Afirmou que o contrato prevê a cobertura para a patologia e inexiste qualquer cláusula contratual que exclua o tratamento indicado pela equipe médica cooperada UNIMED. Pretendeu o deferimento de tutela de urgência para determinar o fornecimento do tratamento. Argumentou sobre a incidência do CDC e requereu a procedência do pedido (evento 1, INIC1). Juntou documentos.

Deferida a antecipação de tutela requerida e determinada a citação (evento 4, DESPADEC1).

A requerida juntou documentos a fim de demonstrar o cumprimento da ordem judicial (evento 18, PET1).

Outrossim, a ré apresentou contestação (evento 19, CONT1), na qual afirmou a legitimidade e licitude da negativa do medicamento pleiteado, uma vez que se trata de medicamento com indicação de uso *off-label*, ou seja, fora da bula registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), estando dito tratamento excluído da cobertura, consoante cláusula décima segunda do contrato firmado entre as partes, sendo autorizado pela lei (art. 10, § 4º, da LPS, e art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000) a vedação da cobertura. Destacou que o medicamento pleiteado não consta no rol de procedimentos da ANS e não tem cobertura obrigatória pela DUT 64 do Rol da ANS para o tratamento de " Carcinoma no Ovário" , tendo cobertura obrigatória apenas para "Melanomas", aludindo que o art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000, atribuiu à ANS a competência de "elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades". Aduziu que o STJ firmou entendimento de que o rol da ANS é taxativo (REsp nº 1.733.013/PR). Requereu a improcedência dos pedidos. Juntou documentos.

Houve réplica (evento 26, RÉPLICA1).

Desprovido o agravo interposto pela ré (processo 5132276-31.2022.8.21.7000/TJRS, evento 18, ACOR2).

Instadas as partes a especificar as provas que pretendiam produzir (evento 30, DESPADEC1), ambas requereram o julgamento do feito (evento 36, PET1 e evento 38, PET1).

É o relatório.

Decido.

Não havendo questões preliminares para apreciação, passo de imediato ao exame do mérito da lide.

Primeiramente, consigna-se que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, uma vez que se trata de relação de consumo, consoante previsão no art. 3º, §2º, do CDC.

Além disso, no caso do plano de saúde, a Súmula 608 do STJ preconiza:

> *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."*

Dessarte, o contrato de Assistência à Saúde - Plano Individual/Familiar, firmado em 07-08-2007, entre a ré Unimed e a autora, deve ser analisado sob a ótica da Lei nº 9.656/98 e do CDC.

Neste contexto, restou incontroverso nos autos que o plano de saúde réu negou à autora o fornecimento do medicamento MEKINIST® (TRAMETINIBE), administrativamente, consoante evento 1, OUT10.

Em contestação, a parte ré reforçou a negativa, argumentando que o medicamento não encontra previsão no Rol de Procedimentos da ANS, porquanto não consta na listagem da Diretriz nº 64 da ANS, sendo a cobertura faculdade da operadora do plano de saúde, razão pela qual pode negá-la, amparada na legislação em vigor.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora tem diagnóstico de carcinoma seroso de baixo grau EC IV desde 2006, tendo realizado vários procedimentos cirúrgicos e quimioterápicos desde então, contudo, a doença segue se manifestando com progressões ao longo do tempo. Nos últimos exames, verificada a nova progressão da doença em abdome, e diante da falta de resposta à quimioterapia, foi feita a indicação do medicamento TRAMETINIBE 2mg via oral, uma vez ao dia, conforme explicado no relatório médico do evento 1, LAUDO9. Com relação ao diagnóstico, não houve impugnação pela ré. A oposição, em realidade, se deu contra o fármaco postulado, entendendo a ré que estes não estão previstos no Rol de Procedimentos da ANS para o tratamento da doença que acomete à autora.

Relativamente ao entendimento da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é taxativo, o entendimento não restou pacificado no âmbito da Corte Superior. Por conseguinte, deve prevalecer no caso em análise o posicionamento jurídico majoritário adotado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no sentido de que o rol é meramente exemplificativo, conforme julgados que seguem:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARCINOMA NEUROENDÓCRINO. MEDICAMENTO BEVACIZUMABE (AVASTIM). TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA. I. INICIALMENTE, A OBRIGAÇÃO DE FAZER RESTOU IMPOSTA À UNIMED PORTO ALEGRE, SENDO QUE NA RÉPLICA APRESENTADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, A DEMANDANTE INFORMA QUE A TUTELA DE URGÊNCIA ESTÁ SENDO CUMPRIDA POR TAL OPERADORA. ADEMAIS, A QUESTÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO PELA UNIMED PORTO ALEGRE E DA LEGITIMIDADE DA UNIMED REGIONAL MARINGÁ AINDA NÃO FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO A QUO, NÃO PODENDO SER ANALISADA POR ESTE TRIBUNAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. II. DE ACORDO COM A REDAÇÃO DO ART. 300, CAPUT, DO CPC, PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA MOSTRA-SE NECESSÁRIA A PRESENÇA DOS SEGUINTES PRESSUPOSTOS: A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. III. NO CASO CONCRETO, ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA POSTULADA. ACONTECE QUE OS DOCUMENTOS MÉDICOS ACOSTADOS NO EVENTO 1 DOS AUTOS ORIGINÁRIOS DEMONSTRAM QUE A AUTORA, ORA AGRAVADA, FOI DIAGNOSTICADA COM GLIOBASTOMA DIFUSO (CID10 C72.9), SENDO INDICADA A REALIZAÇÃO COM O MEDICAMENTO BEVACIZUMABE (AVASTIM). IV. ADEMAIS, O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ESTÁ SUBMETIDO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DA SÚMULA 608, DO STJ, DEVENDO SER INTERPRETADO DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL À PARTE FRACA NA RELAÇÃO, NA FORMA ART. 47, DO ALUDIDO DIPLOMA. V. DA MESMA FORMA, OS PLANOS DE SAÚDE APENAS PODEM ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA, NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE, AINDA QUE NÃO HAJA PREVISÃO NO ROL DA ANS, MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, OU NÃO ATENDIDA EVENTUAL DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. VI. ALIÁS, CONFORME ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O LOCAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO É IRRELEVANTE PARA DEFINIR O DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. EM OUTRAS PALAVRAS, SE HÁ COBERTURA PARA A DOENÇA, DEVE SER FORNECIDO O MEDICAMENTO MINISTRADO PELO MÉDICO, MESMO QUE PARA USO DOMICILIAR. VII. AFORA ISSO, **QUANDO UM MEDICAMENTO É APROVADO PARA UMA DETERMINADA INDICAÇÃO, NÃO SIGNIFICA QUE ESTA SEJA A ÚNICA POSSÍVEL. ALIÁS, NA MAIORIA DAS VEZES, O USO OFF LABEL DE UM MEDICAMENTO PODE SER ESSENCIALMENTE NECESSÁRIO E CORRETO PARA OUTRAS DOENÇAS, DEPENDENDO TÃO-SOMENTE DO ENTENDIMENTO DO MÉDICO ASSISTENTE. VIII. PORTANTO, SE HOUVE INDICAÇÃO DO TRATAMENTO POSTULADO, DESCABE, PELO MENOS NESTE MOMENTO, AO INÍCIO DA LIDE, EVENTUAL NEGATIVA DE COBERTURA, O QUE PODE CAUSAR PREJUÍZO IRREPARÁVEL À SAÚDE E À VIDA DA AGRAVADA**. AGRAVO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50591911220228217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 27-07-2022). Grifei.*
>
> *APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. MEDICAMENTO. REGORAFENIBE (STIVARGA). TRATAMENTO DE ADENOCARCINOMA DE CÓLON. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. COBERTURA DEVIDA. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, pois tal incumbência é do profissional que assiste o paciente, a quem compete avaliar os riscos e benefícios do tratamento e indicar a alternativa mais adequada (STJ, Resp nº 668.216-SP, j. 15.03.2007). **O rol de procedimentos previsto nas normas da ANS não é taxativo, traduzindo somente um referencial de coberturas básicas para os planos de saúde. Precedentes do TJRS**. **A ANS não veda o uso off label de um medicamento com registro na ANVISA e comercialização nacional, o que não se confunde com tratamento experimental a que alude o art. 10 da Lei 9.656/98.** Precedente do STJ. No caso dos autos, o laudo médico e a prescrição atestam que a autora foi diagnosticada com "Adenocarcinoma de Cólon estágio IV (CID C18.9), necessitando fazer uso da substância Regorafenibe (nome comercial Stivarga), o qual está registrado na ANVISA sob o número 170560108. Cobertura devida. Sentença mantida no ponto. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCABIMENTO. Não havendo comprovação adequada dos danos morais alegadamente experimentados, afigura-se descabida a indenização pleiteada. Redimensionamento da sucumbência. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083936955, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 30-04-2020). Grifei.*

Assim, constatada a necessidade do medicamento em questão solicitado pela médica que atende a autora, tendo em vista sua grave situação de saúde, sendo portadora de carcinoma seroso de baixo grau EC IV, mutação KRAS-Q61R, infiltrado e metastático, e já tendo feito uso de procedimentos cirúrgicos e tratamento quimioterápicos disponíveis para sua doença, a fim de proporcionar uma alternativa terapêutica para sua situação clínica, tem-se que não há justificativa para a negativa apresentada.

A propósito, cita-se decisão proferida em agravo da decisão que deferiu a tutela antecipada nestes autos:

> ***AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRAMETINIBE. PREVISÃO NO ROL DA ANS. DOENÇA DIVERSA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO.***
>
> ***1)*** *Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada de origem que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela postulada, para o fim de determinar que a agravante forneça à agravada o medicamento TRAMETINIBE (nome comercial Mekinist®), dose de 2mg ao dia, até o deslinde do feito, a ser cumprido no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária por dia de descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 dias-multa.*
>
> ***2)*** *Compete a ANS (art.4º), dentre outras diretrizes, elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirá referência básica de assistência (inc.III), com o escopo de garantir um plano de saúde e assistência mínimo de caráter privado, atento às evoluções tecnológicas, sem prejuízo da faculdade da contratação de cobertura mais extensa.*

3) Em procedimento de overruling, no julgamento do Recurso Especial 1.733.013/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, restou consolidado que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamentos e/ou medicamentos não incluídos no rol de procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde.

4) No caso em comento, o tratamento indicado se trata de medicação antineoplásica, necessária para o tratamento de saúde da autora, portadora de Carcinoma de Ovário Seroso de Baixo Grau (CID 10 C56), EC IV, mutação KRAS-Q61R, infiltrado e metastático. A cobertura foi negada pela requerida, sob o argumento de que o medicamento postulado não consta no rol da ANS para a moléstia que acomete a autora.

5) Sem razão a negativa de cobertura, visto que o medicamento, objeto da lide está incluído no rol da ANS, ainda que para finalidade diversa da que postulada. Havendo previsão de cobertura no rol da ANS, o médico assistente é quem decidirá se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações de uso daquele específico remédio, tornando inviável que a operadora do plano se negue a cobrir o tratamento sob a justificativa de que a moléstia do segurado não está contida nas indicações de utilização do medicamento, considerando que representaria inegável ingerência na ciência médica, em prejuízo do paciente enfermo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (processo 5132276-31.2022.8.21.7000/TJRS, evento 18, ACOR2).

Outrossim, o contrato prevê cobertura para a patologia que acomete a autora, qual seja, o câncer, bem como, o tratamento quimioterápico, negando a parte ré a cobertura tão-somente porque o medicamento em questão não está no rol dos medicamentos de cobertura obrigatória, conforme DUT 64 do Rol da ANS para o tratamento de " Carcinoma no Ovário" , tendo cobertura obrigatória apenas para "Melanomas". Dessa forma, considerando a imprescindibilidade do fármaco, deve prevalecer a cobertura contratual de modo genérico, sob pena da cláusula ser considerada abusiva ou ser interpretada de forma restritiva à luz do artigo 54 do CDC.

Outrossim, consoante destacado no referido acórdão proferido em agravo interposto contra decisão proferida nestes autos:

*Em razão de tal legitimidade, destaco, por oportuno, que em 24/02/2021, a ANS aprovou nova Resolução Normativa (RN) n° 465/2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, definindo, então, **a cobertura mínima** a ser observada nos planos de saúde, a classificação dos procedimentos, bem como eventuais carências que devem ser observadas, atendendo, na integralidade, as disposições da Lei nº 9.656/98, dispondo sobre os novos exames e tratamentos que passam a fazer parte da lista obrigatória dos planos de saúde, guardadas as obrigações respectivas nos contratos de planos de atendimento ambulatorial, nos de internação hospitalar, os com obstetrícia e os com atendimento odontológicos, prevendo, inclusive, a taxatividade do rol, nesse sentido, **sic**:*

*Art. 2º Para fins de cobertura, **considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos**, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde.*

Nesse contexto, é essencial que o tratamento/medicamento conste como sendo de cobertura obrigatória nos termos das diretrizes normatizadas pela ANS (rol), agência reguladora do setor, ressaltando ser ilícita a cláusula contratual que disponha a respeito de exclusão de tratamento/medicamento, quando, claramente presente a cobertura no rol de cobertura básica, por se tratar de cobertura mínima obrigatória, o que enseja a aplicação do disposto no artigos 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

*Por outro lado, em recentes julgados do egrégio STJ, verifico que restou consolidado que é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, **salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados)**, a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art.17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).*

*Destarte, **no caso em comento**, o tratamento indicado **se trata de medicação antineoplásica**, necessária para o tratamento de saúde da autora, portadora de CARCINOMA DE OVÁRIO SEROSO DE BAIXO GRAU (CID 10 C56), EC IV, mutação KRAS-Q61R, infiltrado e metastático.*

Nesse contexto, a exclusão de cobertura se mostra abusiva, devendo a seguradora fornecer a medicação requerida nos termos do laudo prescrito pela médica responsável pelo tratamento da autora, porquanto cabe ao profissional médico prescrever qual o melhor tratamento ao seu paciente, não ao plano de saúde. Ainda sobre o tema, cita-se:

Confira-se a jurisprudência:

*APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. MEDICAMENTO. DEVER DE COBERTURA RECONHECIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. Trata-se 'de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora postula seja autorizado o fornecimento dos medicamentos DABRAFENIB (TAFINLAR®) + TRAMETINIB (MEKINIST®), bem como indenização a título de danos morais, julgada parcialmente procedente na origem. COBERTURA SECURITÁRIA - É inocultável a incidência e regulação do Código de Defesa do Consumidor, em vista de que se trata de típico contrato de adesão, sendo manifesta a fragilização do pacta sunt servanda, uma vez que o contrato, embora bilateral, resultou em margem mínima de discutibilidade por parte do aderente, utente do crédito e, nessa condição, inferiorizado contratualmente. **Assim, uma vez constatada a necessidade do medicamento em questão solicitado pelo médico que atende o autor (fl. 24), haja vista sua grave situação de saúde**, sendo portador de Neoplasia Maligna da Glândula Tireóide (CID C73) com Doença Metástica Cerebral, Óssea e Pulmonar **e já de tendo feito uso de todas as medicações disponíveis para sua doença, a fim de proporcionar uma alternativa terapêutica para sua situação clínica, tenho que não há justificativa para a negativa apresentada.** Ademais, destaca-se que **o contrato prevê cobertura para a patologia que acomete o autor, qual seja, o câncer, bem como, o tratamento quimioterápico, negando a parte ré a cobertura tão-somente porque o medicamento em questão não está no rol dos medicamentos de cobertura obrigatória, conforme Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS. Mostra-se descabida e abusiva a negativa de cobertura securitária, pois o que deve preponderar é o fato de que há previsão de cobertura para a enfermidade e, inclusive, para o tratamento prescrito ao autor, cabendo ao profissional da saúde, e não à seguradora, a escolha do tratamento.** DANOS MORAIS - A operadora, ao negar cobertura de medicamento, segundo sua interpretação contratual, não pratica ato ilícito ensejador de reparação por dano moral. Oportuno salientar que não estou desconsiderando o suposto desconforto e dissabor que foi experimentado pela parte autora, frente à toda situação exposta no processo. Todavia, a conduta da seguradora não chegou a caracterizar abalo moral propriamente dito. Acrescente-se, ainda, que, no caso concreto, não incide a presunção da ocorrência do efetivo dano moral, pela simples ocorrência do fato em si. Relator vencido no ponto. DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA, POR MAIORIA. E APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA., À UNANIMIDADE.(Apelação Cível, Nº 70082902495, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 13-12-2019).*

Dessarte, deve ser confirmada a decisão proferida em tutela de urgência, a fim de que seja realizada a cobertura do medicamento de que necessita a autora.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I do CPC, JULGO **PROCEDENTE** o pedido veiculado na ação de obrigação de fazer para confirmar a tutela de urgência concedida no evento 4, DESPADEC1, a fim de determinar que a ré forneça o medicamento Trametinibe (nome comercial Mekinist®), dose de 2mg ao dia, enquanto a autora necessitar, sob pena de multa diária por dia de descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 dias-multa.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como honorários de advogado que fixo em 10% do valor da causa, tendo em vista a natureza da ação e trabalho exigido, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

Por derradeiro, tendo em vista a nova sistemática do Código de Processo Civil e, diante da inexistência de juízo de admissibilidade, conforme dispõe o artigo 1.010, § 3º, do CPC, em caso de interposição de recurso de apelação, proceda-se na intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, subam os autos ao egrégio TJRS.

Com o trânsito em julgado, nada requerido no prazo de 5 (cinco) dias, e satisfeitas eventuais custas pendentes, arquive-se com baixa.

Caso não seja efetuado o pagamento das custas, oficie-se ao TJ/RS, a fim de informar o não pagamento, nos termos do Ato 010/2011 - P.

Após, arquivem-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **DEISE FABIANA LANGE VICENTE, Juíza de Direito**, em 10/4/2023, às 15:34:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10036060578v19** e o código CRC **957032fd**.